

EXANTEMAS

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
TIPs Módulo 10 2017 - Dermatología de la SAP 2016

Introducción

El exantema es una erupción aguda generalizada de la piel que puede presentarse como primera manifestación o como parte de la evolución de alguna enfermedad de origen viral o bacteriana, o secundario a ciertos medicamentos o a enfermedades sistémicas.

La mayoría de los exantemas en niños son secundarios a infecciones virales. Algunos de éstos son característicos y es posible hacer un diagnóstico presuntivo por su presentación clínica. Otros son inespecíficos: generalmente eritematosos y/o papulares y con distribución difusa.

Dentro de los exantemas virales podemos encontrar:

Exantemas por Enterovirus

Incluyen a los **echovirus**, los **coxsackievirus**, los **enterovirus A** y los **poliovirus**. La diseminación se produce de persona a persona por transmisión fecal-oral u oral-oral. Suelen presentarse en verano, representando los exantemas estivales en el 70% de los casos.

La mayoría de las veces producen infecciones que se manifiestan con fiebre que puede estar acompañada o no por otros síntomas (catarro de vía aérea superior, gastroenteritis) asociados con herpangina. Los enterovirus no polio pueden manifestarse por exantemas no específicos, máculo-papulares, no pruriginosos, que comienzan en cara y evolucionan rápidamente a tronco y extremidades, con o sin petequias.

La incubación es de 3 a 7 días, sin pródromos y dura de 3 a 5 días.

Enfermedad boca-mano-pie

Afecta a niños de 1 a 4 años.

Es causado por **Coxsackie A16** y otros enterovirus no polio. Es muy contagioso y se observa con mayor frecuencia a fines de verano y durante el otoño. La incubación es de 3 a 7 días, generando inmunidad duradera y no requiere tratamiento. El curso es autolimitado.

Se manifiesta con fiebre, malestar y exantema acral, bilateral y simétrico con vesículas blanco grisáceas rodeadas de un halo eritematoso en palmas y plantas, además de un exantema máculo-papular menos específico en glúteos, muslos y genitales que involuciona en aproximadamente 1 semana. En boca (mucosa yugal, paladar, lengua, etc), los pacientes presentan enantema con vesículas y erosiones que ocasionan gran molestia por dolor y a veces deshidratación y anorexia.

También muestran adenopatías cervicales y submaxilares.

En paciente con eccema puede verse una infección cutánea diseminada.

Las infecciones producidas por enterovirus pueden resultar en cuadros más graves.



Quinta enfermedad o eritema infeccioso o megaloeritema

Es una enfermedad exantemática benigna y autolimitada. Causada por el **parvovirus humano B19**.

Afecta a los niños entre los 5 y 15 años. Si bien el contagio se produce por vía aérea, tiene baja contagiosidad y deja de contagiar cuando aparece el exantema, excepto en inmunodeprimidos y en pacientes con crisis aplásicas. Por lo cual no se justifica la exclusión escolar ni el aislamiento una vez iniciada la sintomatología. La infección deja inmunidad permanente.

En un 20-50% de los casos cursa de forma asintomática.

En el período prodrómico aparecen fiebre baja, cefalea, astenia, odinofagia, mioartralgias. Al 3° o 4° día aparece un eritema facial máculo-papuloso de color rojo intenso que deja indemne la zona perilabial y se conoce como el “signo de las cachetada”. Esta erupción dura de 3-4 días, se desvanece y al día siguiente aparece un exantema confluyente con aclaramiento central y aspecto reticulado o “de encaje”, simétrico, en la cara extensora de brazos y muslos, luego a la cara flexora y por último a glúteos y tronco. Respeto palmas y plantas. Se desvanece hasta desaparecer en 2 o 3 semanas pero puede recurrir ante estímulos como la exposición solar, altas o bajas temperaturas, estrés o actividad física. El prurito es leve o ausente. Puede haber enantema.

Los síntomas articulares son más comunes en adultos que en niños.

También se ha vinculado al Parvovirus a eritrodermia, cuadros vasculíticos sistémicos como Schonlein-Henoch, panarteritis nodosa y Enfermedad de Kawasaki.

Para el diagnóstico se tiene en cuenta la clínica. El virus puede aislarse del suero, orina y secreciones respiratorias. Las pruebas serológicas de RIE y ELISA detectan IgM e IgG específicas.

No hay tratamiento específico.



Sexta enfermedad o roséola infantil o exantema súbito del lactante

Es una enfermedad exantemática leve y autolimitada. Producida por herpes virus tipo 6 y 7.

Afecta por lo general a menores de 3 años, con un pico entre los 6 y los 15 meses.

Tiene mayor incidencia de presentación en los meses de otoño y primavera. La vía de transmisión es principalmente por saliva pero también está bien documentada la transmisión horizontal de madre a hijo.

El período de incubación es de 3-15 días. El cuadro comienza con fiebre alta que dura de 3 a 5 días, irritabilidad e hiporexia. Se pueden presentar también cefalea, faringitis, otitis media, dolor abdominal, convulsiones febriles y linfadenopatías occipitales, cervicales y retroauriculares. El edema periorbitario es un hallazgo común. Al declinar la fiebre, clásicamente en forma abrupta, aparece un exantema macular o máculo-papular discreto, de color rosa pálido, no confluyente, que se localiza en el tronco y luego en el cuello, extremidades y cara. En ocasiones se circunscribe al tronco. No es pruriginoso.

Dura de 1 a 3 días o desaparece en horas. Puede haber brotes secundarios, pero es poco común.

Como otros virus herpes, quedan latentes luego de la primera infección y se pueden reactivar en caso de compromiso inmunológico.

Se puede realizar serología para el diagnóstico pero no se realiza de rutina ante clínica compatible.

Varicela

Es la infección exantemática más frecuente en los niños. El virus varicela-zóster pertenece a la familia de los Herpesvirus. Produce varicela como primoinfección, y se establece definitivamente en forma latente en ganglio sensitivo, con probabilidad de reactivarse en un dermatoma resultando en un **herpes zóster**.

Se han descrito casos de varicela y herpes zóster de aparición simultánea.

Es una infección autolimitada. La distribución es universal y es altamente contagiosa.

Principalmente se observan los casos a fines del invierno y principios de la primavera.

La edad de presentación es el 50% en menores de 5 años y el 90% en menores de 15 años.

Se transmite por contacto directo o aerolización del líquido proveniente de vesículas o a partir de secreciones respiratorias. También se puede adquirir a partir del contacto directo con lesiones activas de herpes zóster.

El contagio puede ocurrir desde 2 días antes del brote hasta que todas las lesiones se encuentren en el estadio costroso.

En el período pródromico puede haber fiebre leve, malestar, anorexia, cefalea y mioartralgias. Luego de 24-48 hs. aparece el exantema. Es polimorfo con lesiones eritemato - pápulo -vesiculosas, de rápida evolución a costras. La erupción progresa desde el cuero cabelludo, cara y tronco hasta las extremidades, incluídas las palmas y las plantas.

El síntoma característico es el prurito. Las lesiones aparecen en brotes sucesivos durante los primeros 5 días. A los 7 días, la mayoría de los pacientes se encuentra en estadio costroso. Las costras caen espontáneamente en 1 a 3 semanas dejando hipopigmentación y lesiones cicatrizales atróficas ante sobreinfección y/o traumatismo por rascado. Existe afectación de las mucosas oral, conjuntival y genital, con vesículas y erosiones dolorosas.

La complicación más común es la sobreinfección bacteriana por *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus Pyogenes*. Las infecciones varían desde el impétigo hasta celulitis, forúnculos, abscesos e infecciones invasivas como síndrome del shock tóxico y fascitis necrotizante; aunque éstas han disminuido mucho luego de la aparición de la vacuna.

Sigue en frecuencia de complicaciones la afectación del SNC con encefalitis, meningoencefalitis, ataxia cerebelosa o síndrome de Guillain-Barré.

Se ha descrito también el síndrome de Reye al ingerir ácido acetilsalicílico en el curso de una varicela.

Este cuadro se caracteriza por encefalopatía aguda y alteraciones de la función hepática.

La neumonía es una complicación que se da más frecuentemente en adultos, mientras que en niños sanos es infrecuente, a menos que se deba a un origen bacteriano.

La varicela hemorrágica es infrecuente pero potencialmente mortal. Las vesículas tienen contenido hemorrágico y además se acompaña de petequias, equimosis, fiebre alta y síntomas generales graves.

Existen tres grupos de pacientes en los cuales la varicela es potencialmente peligrosa: inmunocomprometidos, embarazadas y recién nacidos.

En pacientes inmunocomprometidos la varicela es monomorfa, progresiva, con lesiones vesiculosas hemorrágicas y las complicaciones son más severas.

Las embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones, en especial neumonía y partos prematuros.

La varicela congénita produce RCIU, cicatrices retráctiles en piel, microcefalia, atrofia cortical, coriorretinitis, hipoplasia y paresia de extremidades, cataratas, etc. si el contagio se produjo en la primera mitad del embarazo. El diagnóstico se realiza por clínica y dosaje de IgM específica o IgG más allá del año de vida.

Con respecto a la varicela neonatal: cuando la embarazada se contagia varicela 5 días antes y hasta 2 días después del parto el cuadro es severo con mortalidad del 30% y se manifestará entre el día 1 y 16 de vida.

Si la infección materna se da entre los 5 a 21 días previos al parto la infección neonatal se manifestará en los primeros 4 días de vida y es de pronóstico favorable.

El tratamiento de la varicela es básicamente sintomático:

- Alivio del prurito: antihistamínicos sistémicos, antipruriginosos tópicos.
- Prevención de infecciones: baños frecuentes con jabones neutros o hipoalergénicos, uñas limpias.
- Tratamiento de la sobreinfección bacteriana: antibióticos tópicos o sistémicos.
- Prevención del síndrome de Reye: no indicar ácido acetilsalicílico.
- El uso de aciclovir por vía oral dentro de las 24-72 horas del inicio del exantema genera una disminución en la duración y magnitud de la fiebre y en el número y duración de las lesiones cutáneas.

Debe considerarse en personas sanas con riesgo de varicela moderada a grave como:

- Los individuos mayores de 12 años
- Personas con trastornos cutáneos o pulmonares crónicos
- Pacientes que reciben tratamiento crónico con salicilatos y los individuos que reciben series cortas o intermitentes de corticoides.
- Debe ser considerado en casos familiares secundarios (a partir de segundo contacto) en los cuales la enfermedad suele ser más grave.
- También en pacientes que presentan complicaciones graves.
- No está recomendado en la mujer adolescente o adulta embarazada, ya que no se conocen efectos adversos.
- En pacientes inmunodeprimidos debe administrarse aciclovir endovenoso en las primeras 24 o 72 horas de la varicela.
- En individuos sanos que estuvieron expuestos a varicela puede considerarse la vacuna dentro de los 3 días postexposición y el uso de aciclovir por vía oral durante el período de incubación tardío a los 7-9 días del contacto.
- En embarazadas, recién nacidos de madre con varicela 5 días antes del parto y hasta 48 horas posparto, prematuros, inmunosuprimidos, quemados, pacientes con enfermedad fibroquística del páncreas, pacientes bajo tratamiento quimioterápico o con corticoterapia crónica, etc. que tuvieron contacto con varicela, estaría indicada gammaglobulina específica IM dentro de las 96 horas, ya que el uso de aciclovir en estos pacientes es controvertido.

Virus Epstein-Barr (VEB)

Es una infección común de niños y adolescentes. En niños menores la infección es frecuentemente inaparente o leve e inespecífica, por lo que su diagnóstico pasa inadvertido, y en niños mayores y adolescentes es mayor la tendencia a síntomas clínicos de mononucleosis infecciosa.

El virus replica en los linfocitos B y las células epiteliales de la mucosa bucal. Los linfocitos B infectados pasan a la circulación y se movilizan hacia los diversos órganos linfoides secundarios.

En regiones subdesarrolladas tiene mayor incidencia en niños de primera infancia, y el contagio es favorecido por el hacinamiento y la baja higiene; en regiones desarrolladas, por otro lado, tiene mayor incidencia en mayores de 15-25 años, favorecido por el contacto interpersonal íntimo.

La saliva es la principal vía de transmisión.

Puede dar exantema en distintas situaciones clínicas:

- A)** Mononucleosis infecciosa: fiebre alta y prolongada, astenia, cefalea, faringoamigdalitis aguda, linfadenopatías múltiples, no dolorosas. A veces puede hallarse hepatoesplenomegalia. El exantema es inespecífico y se presenta sólo en el 5-15% de los casos y, en menores de 3 años, en el 30%. Patrón variable, principalmente máculo-papular, morbiliforme, en tronco y brazos. También puede ser petequial y purpúrico o urticariano. Aparece durante la primera semana de la enfermedad y dura de 1 a 7 días. No tiene tratamiento específico.
- B)** Pacientes con infección por VEB medicados con antibióticos beta lactámicos, principalmente amoxicilina: exantema máculo-papular, morbiliforme extenso que incluye palmas y plantas a los 7-10 días de comenzado el antibiótico.
- C)** Síndrome de Gianotti-Crosti (acrodermatitis papular de la infancia): exantema eritematoso o de color piel normal, papular, simétrico y monomorfo, de aspecto liquenoide en cara, extremidades y nalgas. En codos y rodillas las pápulas pueden coalescer y formar placas edematosas. El tronco suele estar respetado y no hay enantema acompañante. Habitualmente no es pruriginoso y resuelve espontáneamente en 3 a 4 semanas. Se observa principalmente en niños de 1 a 4 años y en meses de primavera y verano. La mayoría de los casos son esporádicos, pero existen brotes familiares. También se lo ha asociado a infección por virus de la hepatitis B y otros e inmunizaciones previas.

Sarampión

Es una infección grave y potencialmente fatal. El virus del sarampión pertenece a la familia Paramixoviridae (ARN). Es muy contagioso y se transmite a través de las microgotas de flugge o en forma indirecta por fómitemos.

El período de contagio se extiende desde 1 ó 2 días antes del comienzo hasta 5 días después de la aparición del exantema.

Tiene presentación endemoepidémica, con un mayor número de casos en los meses de invierno, pero cada 2 a 4 años.

La edad de presentación habitual abarca a los menores de 5 años (principalmente menores de 2 años) y puede prolongarse hasta los 9 años.

Una vez que se padece la enfermedad, deja inmunidad de por vida.

Se caracteriza por astenia, fiebre leve a moderada e hiporexia. En este período aparece el "triple catarro": conjuntival (conjuntivitis), nasal (coriza) y faringolaringotraqueobronquial (tos). Además hay un enantema patognomónico: "manchas de Koplik" caracterizadas por pápulas blanco grisáceas sobre un fondo eritematoso difuso, ubicadas en la mucosa yugal frente a los molares inferiores. Desaparecen en 12 a 18 horas.

Luego comienza el período de estado que se inicia con un nuevo pico febril de 38-39°C, que anuncia la segunda viremia. Aquí aparece el exantema máculo-papuloso de

color rojo que tiende a confluir y deja zonas de piel sana entre las lesiones. Comienza en la cara y se extiende en sentido céfalocaudal. Puede acompañarse de leve prurito. La duración del rash es de aproximadamente 1 semana.

Usualmente se observan adenopatías submaxilares y cervicales con leve esplenomegalia.

La gravedad de la enfermedad es directamente proporcional a la extensión y confluencia del exantema.

Existe una forma de sarampión atípico debido a una respuesta inmune celular alterada. Se caracteriza por fiebre alta, triple catarro con neumonitis y derrame pleural, edema periférico y rash máculo-vesiculopurpúrico que compromete principalmente manos y pies.

El diagnóstico del sarampión puede realizarse a partir de:

- Antecedentes epidemiológicos y clínica.
- Hemograma: leucopenia en el período de incubación y leucocitos normales o ligeramente elevados con linfocitosis durante el exantema.
- El virus se aísla de la sangre, orina, LCR y secreciones respiratorias.
- Serología con dosaje de IgM e IgG específicas.

El tratamiento del sarampión consiste en:

- Reposo y aislamiento durante el período de invasión y de estado
- Lavado ocular con solución fisiológica
- Fluidificación de las secreciones con nebulizaciones
- Antibióticos en caso de sobreinfección bacteriana
- En los primeros tres días tras el contacto la vacuna específica puede ser de utilidad para evitar la enfermedad. Y en pacientes desnutridos e inmunocomprometidos se recomienda el uso de inmunoglobulina específica postexposición.

Rubéola

Es una enfermedad viral autolimitada. Afecta por lo general a niños pequeños, en edad escolar. En el embarazo puede dar origen al síndrome de rubeola congénita.

El contagio es generalmente por las secreciones nasofaríngeas de las personas clínicamente enfermas o con enfermedad inaparente. En menor proporción, puede también propagarse a través de fómitemos.

El contagio se extiende desde 7 días antes de la aparición de la erupción hasta 7 días después del comienzo de ésta. En los niños con rubeola congénita el contagio se extiende hasta el año de edad a través de secreciones nasofaríngeas, orina y sangre. Deja inmunidad permanente.

El 50% de los casos cursa de forma asintomática y son frecuentes las formas leves y autolimitadas.

Se caracteriza por pródromos como febrícula, cefalea, malestar, anorexia, mialgias, dolor ocular, coriza, conjuntivitis, odinofagia y tos 2 a 5 días previos a la aparición del exantema.

Además, es usual la presencia de adenomegalias suboccipitales, retroauriculares y cervicales posteriores que persisten hasta 7 días o más luego de finalizada la erupción.

El período de estado comienza con una erupción máculo-papular rosada, universal, de progresión céfalocaudal, con generalización rápida y duración efímera. Deja una fina descamación residual.

Es importante destacar que:

- las adenomegalias persisten varias semanas después de finalizada la erupción
- la esplenomegalia no es un hallazgo habitual
- a nivel de los codos, rodillas, muñecas y dedos pueden producirse artralgias migratorias que resuelven en semanas.

Las complicaciones incluyen encefalitis, neuritis óptica, miocarditis, pericarditis, hepatitis, etc.

Virus	Enfermedad o Síndrome	Incubación (días)	Estación principal	Características clínicas	Exantema	Distribución	Duración	Edad más FR.
					Lesiones			
Parvovirus B19 (5° enfermedad)	Megaloteritema, Sme. de guantes y calcetines	7 a 17 días	Invierno y primavera	Enfermedad bifásica, período prodromico con dolor de cabeza y malestar general, seguido de exantema morbiliforme	Exantema en las mejillas tipo cache-tada y erupción eritemato máculo-papular en tronco y extremidades	Comienza en la cara. Más prominente en la superficie de extensión de las extremidades	7 a 21 días	5 a 15 años
Adenovirus tipos 1, 2, 3, 4, 7 y 7a		6 a 9 días	Invierno y primavera	Fiebre y signos y síntomas de enfermedad respiratoria Ocasionalmente roseola-like	Lo más común es eritematoso máculopapular (rubeoliforme) pero en ocasiones confluyente (morbiliforme) Rara vez eritema multiforme y Sme. Steven Johnson	Usualmente comienza en la cara y se extiende hacia tronco y extremidades	3 a 5 días	
Herpes simplex tipo 1 y 2	Herpes labial, genital, neonatal, etc.	2 a 12 días	No estacional	Enfermedad primaria asociada a fiebre y síntomas sistémicos Enfermedad recurrente ocasionada en forma endógena y exógena	Lesiones solas o agrupadas de 2 a 10 mm sobre una tenue base eritematosa Ocasionalmente eritema multiforme, Sme. Steven Johnson y eritema nudoso	Lesiones primarias del tipo 1 principalmente en y alrededor de la boca Formas recurrentes tipo 1 en la boca Formas primarias y recurrentes del tipo 2 principalmente a nivel genital	7 a 14 días	
Herpes virus humano tipo 6 (VHH-6) (6° enfermedad)	Roseola infantum		No estacional	Fiebre de 3 a 5 días de duración, rápida defervescencia y luego la aparición del exantema	Eritematoso macular y máculo-papular	Principalmente en cuello y tronco Cara y extremidades pueden ser afectadas	1 a 2 días	< 3 años (pico: 6 a 15m)
Herpes virus humano tipo 7 (VHH-7) (6° enfermedad)	Roseola infantum		No estacional	Fiebre de 3 a 5 días de duración, rápida defervescencia y luego la aparición del exantema	Eritematoso macular y máculo-papular	Principalmente en cuello y tronco Cara y extremidades pueden ser afectadas	1 a 2 días	
Herpes virus humano tipo 8 (VHH-8)	Sarcoma Kaposi	meses a años	No estacional	Infección asintomática Mas frecuente en SIDA pero ocurre en otras inmunodeficiencias	Nódulos purpúricos a azulados	En cualquier superficie de piel o mucosas	meses a años	
Varicela-zóster	Varicela	12 a 20 días	Terminando el otoño, invierno o primavera	Malestar y fiebre de 5 días de duración	Lesiones que evolucionan desde máculas a pápulas vesículas y costras. Polimorfismo local y regional Lesiones ocurren en brotes	Lesiones más marcadas en el tronco que en las extremidades	8 a 10 días	< 5 años
	Herpes-zóster		No estacional	Infección endógena Dolor y parestesia con distribución dermatomérica	Lesiones que evolucionan desde máculas a pápulas vesículas y costras.	Lesiones localizadas en una dermatómera	10 a 28 días	

Virus	Enfermedad o Síndrome	Incubación (días)	Estación principal	Características clínicas	Exantema	Distribución	Duración	Edad más FR.
					Lesiones			
Epstein-Barr	Mononucleosis Infecciosa	28-49 días	No estacional	Fiebre, faringitis y adenopatías El exantema ocurre en el 3 a 13% de los casos Si se administra ampicilina el exantema aparece en el 50 a 80% de los casos	Más frecuentemente macular o máculopapular discreto (rubeoliforme) En relación a la administración de ampicilina el exantema puede ser más intenso Puede ocurrir exantema multiforme y urticariano	Principalmente en el tronco y extremo proximal de extremidades	2 a 7 días	El exantema es más frecuente en < 3 años y en los medicados con β -lactámicos
Citomegalovirus	Mononucleosis por Citomegalovirus		No estacional	Leve cuadro febril con adenopatías Congénita: enfermedad diseminada	Eritematoso macular y máculopapular discreto Vesicular o petequeial en la forma congénita	Localizado principalmente en tronco y extremidades	2 a 7 días	
Coxsackievirus A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10, y A16; coxsackievirus B1-B5; echovirus 1-7, 9, 11-14, 16-19, 24, 25, 30, y 33; enterovirus 71; parechovirus 1 y 3 (pie, mano, boca)		4 a 7 días	Verano y otoño	Fiebre y leve faringitis Ocasionalmente herpangina, meningitis u otras manifestaciones de infección viral Exantema ocurre en cerca 5 a 50% de los casos dependiendo del tipo de virus El exantema ocurre durante la fiebre o la defervescencia; Sme. de boca, mano y pie	Más comúnmente eritematoso máculopapular discreto Puede haber elementos maculares, vesiculares, petequeiales Rara vez eritema multiforme	Usualmente comienza en la cara y se extiende hacia tronco y extremidades Puede haber distribución periférica, Sme. boca, mano y pie	3 a 7 días	1 a 4 años
Rinovirus (varios tipos)		2 a 4 días	Otoño, invierno y primavera	Leve fiebre y signos y síntomas respiratorios Exantema en el 5% de los casos	Eritematoso máculopapular discreto	Comienza en tronco y se disemina a las extremidades	1 a 4 días	
Rotavirus	Síndrome de Gianotti-Crosti; edema agudo hemorrágico infantil	2 a 4 días	Otoño, invierno y primavera	Gastroenteritis	Petequeial y morbiliforme	Generalizado	7 a 14 días	

Virus	Enfermedad o Síndrome	Incubación (días)	Estación principal	Características clínicas	Exantema	Distribución	Duración
					Lesiones		
Chikungunya, o'nyong-nyong, Ross River, Sindbis			Durante períodos de prevalencia del mosquito	Fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, mialgias y artralgias Enfermedad localizada geográficamente	Rubeoliforme, morbiliforme Frecuentemente vesicular y petequiral	Comienza en cara y se disemina a tronco y extremidades	
Rubéola	Rubéola	15-21 días	Invierno y primavera	Síntomas leves 1 a 5 días antes del rash Fiebre < 38,5° Dolor de cabeza, malestar, adenopatías occipitales y retroauriculares	Eritematoso máculopapular discreto	Comienza en cara y se disemina a tronco y extremidades	7 a 14 días
Dengue y Kunjin		7 días	Durante períodos de prevalencia del mosquito	Comienzo agudo con fiebre, malestar, cefaleas, mialgias y artralgias Fiebre durante 5 a 6 días y termina en crisis Rash aparece a las 48 horas de comienzo de la fiebre Enfermedad localizada geográficamente	Inicialmente macular y luego máculopapular, cara enrojecida Puede ser escarlatiniforme Frecuentemente se vuelve petequiral o purpúrico Pequeñas vesículas ocurren en la infección por el virus Kunjin	Inicialmente macular y predominantemente central Máculopapular puede comenzar en manos y pies y diseminarse al tronco	3 a 10 días
Influenza A y B		2 a 5 días	Otoño, invierno y primavera	Fiebre, tos, dolor de cabeza, mialgias y artralgias Generalmente en niños pequeños puede ocurrir un rash	Eritematoso máculopapular discreto (rubioliforme) Rara vez eritema multiforme	Comienza en cara y tronco y se disemina a las extremidades	1 a 3 días
Virus sincitial respiratorio		2 a 5 días	Otoño, invierno y primavera	Fiebre, tos, coriza, dificultad respiratoria (bronquitis, bronquiolitis, neumonía) generalmente en niños < 2 años	Eritematoso máculopapular discreto (rubioliforme)	Comienza en cara y tronco y se disemina a las extremidades	1 a 3 días
Metapneumovirus humano			Otoño, invierno y primavera	Fiebre, tos, coriza, dificultad respiratoria (bronquitis, bronquiolitis, neumonía)	Eritematoso máculopapular		

Virus	Enfermedad o Síndrome	Incubación (días)	Estación principal	Características clínicas	Exantema	Distribución	Duración
					Lesiones		
Parainfluenza 1-3		2 a 5 días	Otoño, invierno y primavera	Fiebre, tos, coriza, dificultad respiratoria (bronquitis, bronquiolitis, neumonía) Generalmente en niños pequeños	Eritematoso máculopapular discreto (rubioliforme)	Comienza en cara y tronco y se disemina a las extremidades	1 a 3 días
Sarampión	Sarampión	8 a 12 días	Invierno y primavera	Comienza con fiebre, tos, coriza y conjuntivitis Cerca de 2 días después de la fiebre aparece el exantema Manchas de Koplic	Eritematoso, máculopapular confluyente Evoluciona a manchas café con leche y a una fina descamación	Comienza en la frente y detrás de las orejas. Se disemina hacia todo el cuerpo. Confluye en cara, tronco y porción proximal de las extremidades	5 a 7 días
Hepatitis B	Acrodermatitis papular de la niñez	50-180 días		Comienzo insidioso con artralgia, artritis, y rash que ocurre antes de la ictericia	Máculopapular, macular y vesicular En niños pequeños, papular (Síndrome de Gianotti-Crosti o Acrodermatitis papular de la infancia) Rara vez eritema multiforme	Generalizado	4 a 10 días
Ebola	Fiebre hemorrágica	5 a 10 días	Ocurre en brotes	Enfermedad febril que evoluciona a hemorragia, shock y coma	Rash máculopapular aparece al final de la primera semana de enfermedad	Parte lateral del tronco, axilas e ingle Puede ser generalizado pero evita la cara	14-60 días
Hantavirus	Fiebre hemorrágica con síndrome renal		Primavera y verano	Enfermedad febril hemorrágica con falla renal	Enrojecimiento y rash petequeial	Rubor facial, petequias a nivel de los pliegues	14-28 días
Fiebre hemorrágica argentina	Fiebre hemorrágica	5 a 10 días	Otoño	Comienza con fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias	Enrojecimiento y rash petequeial	Parte lateral del tronco, axilas e ingles. Puede generalizarse	meses a años